

Rangkuman Seminar Audit Klinis & Audit Medis Rumah Sakit

Dokumen ini merupakan rangkuman poin - poin penting dari tiga materi seminar terkait Audit Klinis, Audit Medis, PMKP 7, serta simulasi implementasi audit di rumah sakit.

1. Dasar Regulasi dan Tujuan Audit Klinis

- Audit klinis dan audit medis merupakan bagian penting dari tata kelola klinis rumah sakit.
- Dasar hukum utama berasal dari UU No. 17 Tahun 2023, PP No. 28 Tahun 2024, serta KMK No. 1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
- Audit dilakukan untuk menjaga keselamatan pasien, kendali mutu, kendali biaya, dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan.
- PMKP 7 mewajibkan evaluasi penerapan standar pelayanan kedokteran melalui audit klinis/audit medis.
- Tujuan utama audit adalah meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelayanan dan mengurangi variasi pelayanan klinis.

2. Perbedaan Audit Klinis dan Audit Medis

- Audit Medis lebih fokus pada tindakan dokter, keputusan medis, dan rekam medis pasien.
- Audit Klinis memiliki cakupan lebih luas meliputi dokter, perawat, pelayanan penunjang, prosedur, dan sistem pelayanan.
- Audit klinis mengintegrasikan audit medis, audit keperawatan, dan pelayanan klinis lainnya.
- Audit dilakukan bukan untuk menyalahkan individu, tetapi untuk memperbaiki mutu pelayanan.

3. Ciri Audit yang Baik

- Dilakukan secara terbuka dan edukatif.
- Bukan proses mencari kesalahan atau kambing hitam.
- Menjaga kerahasiaan data pasien dan tenaga kesehatan.
- Mendorong teamwork dan patient safety.
- Audit yang baik harus menghasilkan perubahan nyata dan perbaikan berkelanjutan.

4. Tahapan Audit Klinis / Audit Medis

- Menentukan topik audit berdasarkan masalah prioritas, data mutu, medical error, atau clinical pathway.
- Menetapkan tujuan, sasaran, standar, dan kriteria audit.
- Mengumpulkan data melalui rekam medis secara retrospektif maupun prospektif.
- Menganalisis data menggunakan statistik deskriptif dan RCA (Root Cause Analysis).
- Menyusun rencana tindak lanjut (POA/RTL).
- Melakukan re - audit untuk melihat efektivitas perbaikan.

5. Penetapan Kriteria Audit

- Kriteria audit harus spesifik, terukur, dan berbasis guideline/PPK/clinical pathway.
- Kriteria audit bukan kriteria diagnosis.
- Audit dapat menilai proses diagnosis, terapi, tindakan, maupun outcome.
- Contoh indikator: ketepatan waktu CT Scan stroke, pemberian antibiotik, LOS, mortalitas, dan kepatuhan terapi.

6. Pengumpulan dan Analisis Data

- Setiap rekam medis dinilai apakah sesuai kriteria audit.
- Penilaian menggunakan kode: K1 (sesuai), K2 (tidak sesuai tetapi ada justifikasi), K3 (tidak sesuai tanpa justifikasi).
- Data dianalisis untuk melihat tingkat kepatuhan dan pola penyimpangan.
- RCA dan diagram fishbone digunakan untuk mencari akar masalah.

7. Simulasi Audit Klinis

- Contoh kasus audit: Penatalaksanaan Peritonitis akibat Appendicitis Akut Perforasi.
- Audit mengevaluasi ketepatan diagnosis, pemeriksaan penunjang, tindakan operasi, LOS, dan outcome pasien.
- Hasil audit menunjukkan beberapa indikator sudah baik, namun ada masalah pada keterlambatan laparotomi dan pemeriksaan USG.
- Faktor penyebab meliputi SDM, alat, komunikasi antar unit, prosedur CITO, hingga keterbatasan fasilitas.

8. Root Cause Analysis (RCA)

- RCA merupakan metode untuk menemukan akar penyebab masalah, bukan hanya gejalanya.
- Fishbone diagram membantu mengidentifikasi faktor manusia, metode, mesin, material, lingkungan, dan sistem.
- Hasil RCA digunakan untuk membuat Plan of Action (POA) yang realistis dan terukur.

9. Rencana Tindak Lanjut dan Re - Audit

- POA harus memiliki target waktu, pelaksana, dan indikator keberhasilan.
- Perbaikan dapat berupa penambahan SDM, penyediaan alat, penyempurnaan SOP, atau peningkatan komunikasi.
- Re - audit dilakukan untuk memastikan bahwa intervensi menghasilkan peningkatan mutu.

10. Kesimpulan Utama Seminar

- Audit klinis dan audit medis merupakan bagian penting dalam Continuous Quality Improvement (CQI).
- Audit bukan sekadar kewajiban administrasi akreditasi, tetapi alat strategis peningkatan mutu layanan rumah sakit.
- Dokumentasi audit harus sistematis mulai dari pelaksanaan, analisis, rekomendasi, hingga re - audit.
- Data tanpa tindak lanjut tidak memberikan manfaat; audit harus menghasilkan perubahan nyata.

Semoga rangkuman ini membantu dalam memahami konsep audit klinis dan audit medis serta implementasinya dalam peningkatan mutu pelayanan rumah sakit.